

Eliminacja zachowań zabezpieczających

„Podpórki”, które dają ulgę krótkoterminowo — i utrzymują panikę długoterminowo. Bez nich ekspozycja zaczyna leczyć.

CZAS: praca ciągła przez całą terapię Hierarchia + 1 SB na tydzień

ŹRÓDŁO: Salkovskis (1991); Salkovskis i wsp. (1999, RCT); Wells i wsp. (1995)

JAK UŻYWAĆ

Zidentyfikuj wszystkie swoje zachowania zabezpieczające (lista na stronie 2 — minimum 15 typowych). **Uszereguj** od najłatwiejszego do najtrudniejszego do porzucenia. **Wycofuj** po jednym tygodniowo, zaczynając od najłatwiejszego. Dla każdego zapisz prognozę „bez X stanie się Y” i sprawdź po. Najtrudniejsze (lek ratunkowy w kieszeni) — dopiero na końcu, po wielu udanych ekspozycjach.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Salkovskis (1991) zaobserwował, że pacjenci „wykonujący ekspozycję” **nie poprawiali się**, jeśli stosowali subtelne zabezpieczenia. Mechanizm: każde bezpieczne zakończenie sytuacji zostaje fałszywie przypisane zachowaniu zabezpieczającemu (ang. *safety behavior*) — „przeżyłem/-am, bo miałem/-am lek” — nie rzeczywistej nieszkodliwości. Atrybucja blokuje aktualizację przekonania. Salkovskis i wsp. (1999, randomizowane badanie kliniczne): ekspozycja z zabezpieczeniami → minimalna redukcja lęku; ta sama bez zabezpieczeń → duża.

01 📋 Cztery kategorie zachowań zabezpieczających

1 · PRZEDMIOTY „RATUNKOWE”

Lek w kieszeni (alprazolam, lorazepam), butelka wody, cukierki, telefon z numerem ratunkowym, „talizman”. *Posiadanie* wystarcza — nie trzeba używać.

2 · OSOBY „BEZPIECZNE”

Partner, rodzic, znajomy „obok lub w telefonie”. „Z nim się nie boję” = z nim mózg nie aktualizuje przekonania. Pełna ekspozycja wymaga samotności.

3 · POZYCJE I MIEJSCA

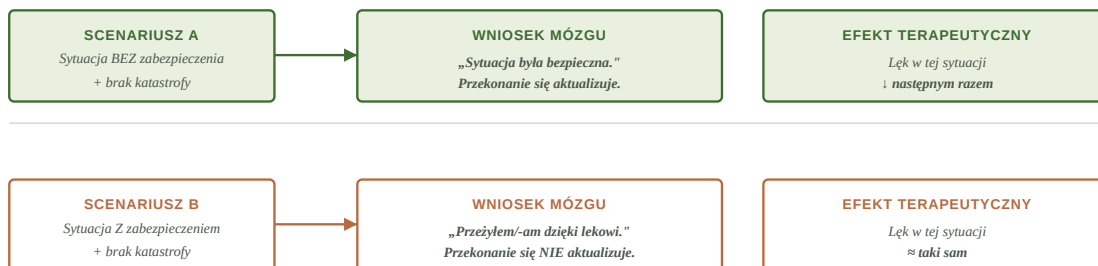
Siedzenie przy wyjściu w kinie, parkowanie blisko sklepu, „znajome trasy”, unikanie godzin szczytu. *Pozornie niewinne* ułatwienia — w sumie składają się na kompletne unikanie.

4 · DZIAŁANIA UKRYTE

Sprawdzanie pulsu, mierzenie ciśnienia, kontrolowanie oddechu, „skanowanie ciała”, trzymanie się ściany/poręczy. Pacjent rzadko zgłasza spontanicznie — pytaj wprost.

02 ❓ Dlaczego ulga nie leczy — paradoks atrybucji

Po sytuacji bez katastrofy — który wniosek wyciąga mózg?



03 Moja lista zachowań zabezpieczających

Zaznacz wszystkie, które stosujesz. Dopisz własne, jeśli brakuje. Następnie uszereguj od **najłatwiejszego** do porzucenia (#1) do **najtrudniejszego** (#N) — kolumna „rank”.

TAK?	ZACHOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE	SUDS PRZY PORZUCENIU	RANK	DATA PORZUCENIA
☐	Lek (alprazolam, lorazepam) w kieszeni / torebce			
☐	Telefon w ręku z numerem ratunkowym			
☐	Towarzysz (partner, znajomy) „dla bezpieczeństwa”			
☐	Siedzenie / stanie blisko wyjścia			
☐	Butelka wody, cukierki „na wszelki wypadek”			
☐	Sprawdzanie pulsu / ciśnienia w trakcie sytuacji			
☐	Unikanie kofeiny, alkoholu, wysiłku			
☐	Płytki, kontrolowany oddech „żeby nie hiperwentylować”			
☐	Trzymanie się ściany, poręczy, mebli			
☐	Unikanie godzin szczytu, tłumów			
☐	Znajome trasy (autobus zamiast metra)			
☐	Dzwonienie / pisanie do bliskich w trakcie			
☐	Słuchawki z muzyką „żeby się rozproszyć”			
☐	Sprawdzanie objawów w internecie po wyjściu			
☐	Własne			

Klucz: najczęstsza pułapka — pacjent „udaje” porzucenie zabezpieczenia, ale zastępuje je innym (odstawił/-a alprazolam, ale wziął/wzięła wodę z cukrem). Wells i wsp. (1995): usunięcie *nawet jednego* zachowania zabezpieczającego daje znaczący spadek lęku. Aktywnie szukaj subtelne zabezpieczenia: „co dokładnie zrobisz/-aś?”, „co miałeś/-aś w kieszeni?”, „gdzie siedziałeś/-aś?” — odsłaniają to, czego pacjent sam nie wymieni.